Commencé le	mardi 27 octobre 2026, 07:45
État	Terminée
Terminé le	mardi 27 octobre 2026, 07:46
Temps mis	29 s
Points	0,60/7,00
Note	**1,71** sur 20,00 (**8,57**%)

Énoncé général

Mme R., 27 ans, consulte pour dyspnée d'effort. En reprenant le sport récemment, elle décrit une dyspnée inhabituelle avec parfois des sifflements dans la poitrine.

- Pas de symptôme nocturne
- 2 à 3 épisodes de bronchite par an aux changements de saison
- Pas de notion d'allergie connue mais consommation de tabac occasionnelle

---

Question 1

Incorrect

Note de 0,00 sur 1,00

Elle apporte avec elle les résultats d'une radiographie thoracique, concernant cet examen :



- a. Il existe une opacité pulmonaire gauche. ✖
- b. Il existe une horizontalisation des arcs costaux. ✔
- c. Il existe un aplatissement des coupoles diaphragmatique. ✔
- d. Il existe une cardiomégalie. ✖
- e. Il existe un pneumothorax droit. ✖

La réponse n'est pas correcte.

Les réponses correctes sont : Il existe une horizontalisation des arcs costaux., Il existe un aplatissement des coupoles diaphragmatique.

Question 2

Incorrect

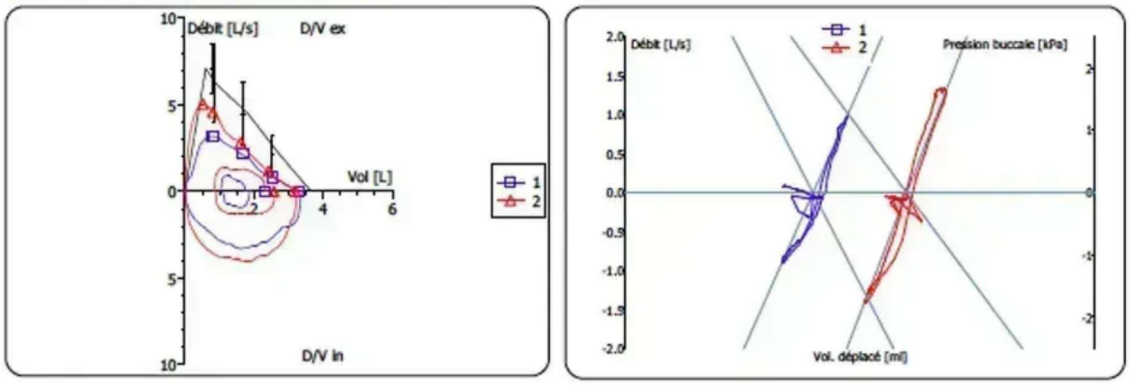
Note de 0,00 sur 1,00

Vous réalisez l'examen suivant :

Nom: [redacted] **Prénom:** [redacted]

Date naissance:	15/10/1982	Age:	27 Ans
Taille:	164,0 cm	Poids:	67,0 kg
Sexe:	féminin		

COURBES DEBIT-VOLUME ET PLETHYSMO



PARAMETRES SPIROMETRIE ET DEBIT-VOLUME

		Théo	Pré	%Théo	Post	%Théo	D%2/1
Date			18/12/09		18/12/09		
Heure			17:40:10		17:54:28		
Substance					<Ventoline		
CVL	[L]	3.69	3.36	90.9	3.22	87.3	-4.0
CVF	[L]	3.65	3.29	90.3	3.19	87.4	-3.2
VRE	[L]	1.29	1.26	98.1	1.02	79.1	-19.3
VEMS	[L]	3.18	2.30	72.3	2.57	80.7	11.7
VEMS % CVL	[%]	83.78	68.48	81.7	79.68	95.1	16.4
DEP	[L/s]	7.07	3.17	44.9	5.03	71.1	58.5
DEM 75	[L/s]	6.18	3.16	51.1	4.56	73.8	44.3
DEM 50	[L/s]	4.48	2.14	47.7	2.81	62.7	31.3
DEM 25	[L/s]	2.13	0.81	38.0	1.18	55.2	45.4
DEMM 25/75	[L/s]	4.02	1.77	44.1	2.39	59.5	34.9
DIP	[L/s]		3.33		4.09		22.8

Concernant cet examen, quelle(s) proposition(s) est(sont) vraie(s) ?

- a. Il existe un syndrome restrictif. ✖
- b. La réalisation de la pléthysmographie est correcte. ✖
- c. Il existe une réversibilité presque significative. ✔
- d. Les résultats avant administration de Ventoline sont normaux. ✖
- e. Il existe un syndrome obstructif modéré avant Ventoline. ✔

La réponse n'est pas correcte.

Les réponses correctes sont : Il existe une réversibilité presque significative., Il existe un syndrome obstructif modéré avant Ventoline.

Question 3

Partiellement correct

Note de 0,20 sur 1,00

Vous considérez que l'examen clinique, radiologique et les EFR sont compatibles avec un asthme. Quels traitements de première attention pouvez-vous proposez ?

- a. Un traitement de secours par Salbutamol ✔
- b. Un bêta mimétique de longue durée d'action seul ✖
- c. Une corticothérapie inhalée en monothérapie ✔
- d. Un antileucotriéne ✔
- e. Un anticholinergique de longue durée d'action. ✖

Vous avez sélectionné trop d'options.
Les réponses correctes sont : Un traitement de secours par Salbutamol, Une corticothérapie inhalée en monothérapie, Un antileucotriéne

---

Question 4

Partiellement correct

Note de 0,20 sur 1,00

Quelle(s) prise(s) en charge associez-vous par ailleurs ?

- a. Arrêt du tabac ✔
- b. Consultation avec un allergologue ✔
- c. Arrêt des exercices physique ✖
- d. Un arrêt de travail ✖
- e. Une évaluation clinique et fonctionnelle dans trois mois ✔

Vous avez sélectionné trop d'options.
Les réponses correctes sont : Arrêt du tabac, Consultation avec un allergologue, Une évaluation clinique et fonctionnelle dans trois mois

---

Question 5

Incorrect

Note de 0,00 sur 1,00

Elle revient en consultation quatre mois plus tard au décours d'un nouvel épisode de bronchite. Elle rapporte, malgré le traitement mis en place, une consommation de Ventoline trois fois par semaine et des épisodes de toux nocturne.

Concernant son asthme :

- a. Il s'agit d'un asthme mal contrôlé. ✔
- b. Le traitement est adapté, il faut poursuivre la même thérapeutique. ✖
- c. Il faut majorer son traitement de fond. ✔
- d. Il faut arrêter la corticothérapie inhalée. ✖
- e. Il s'agit d'un asthme sévère. ✖

La réponse n'est pas correcte.

Les réponses correctes sont : Il s'agit d'un asthme mal contrôlé., Il faut majorer son traitement de fond.

Question 6

Partiellement correct

Note de 0,20 sur 1,00

Vous revoyez cette patiente en urgence. Elle présente une majoration aigue de sa dyspnée associé à une douleur latéro thoracique droite. À l'examen clinique, quels signes cliniques recherchez vous en faveur d'un pneumothorax droit ?

- a. Une abolition du murmure vésiculaire à droite ✔
- b. Une douleur rythmée par la respiration ✔
- c. Un tympanisme à la percussion de l'hémithorax droit ✔
- d. Une toux productive avec une expectoration purulente ✖
- e. Des crépitant à gauche ✖

Vous avez sélectionné trop d'options.

Les réponses correctes sont : Une abolition du murmure vésiculaire à droite, Une douleur rythmée par la respiration, Un tympanisme à la percussion de l'hémithorax droit

---

Question 7

Incorrect

Note de 0,00 sur 1,00

La radiographie thoracique retrouve un décollement de l'apex pulmonaire droit s'étendant jusqu'au hile droit.

Quelles options thérapeutiques peuvent être envisagée pour cette patiente ?

- a. Prise en charge chirurgicale ✖
- b. Repos au lit et surveillance ✔
- c. Exsufflation à l'aiguille ✔
- d. Mise en place d'un drain thoracique de gros calibre en base droite ✖
- e. Prise en charge par vidéo thoracoscopie et symphyse pleurale ✖

La réponse n'est pas correcte.

Les réponses correctes sont : Repos au lit et surveillance, Exsufflation à l'aiguille